

Validierung und Normierung des „Fragebogen zur Erfassung des körperlichen Wohlbefindens“ (FEW-16) von Kolip und Schmidt an einer repräsentativen deutschen Bevölkerungsstichprobe

Cornelia Albani¹
 Gerd Blaser¹
 Michael Geyer¹
 Gabriele Schmutzer²
 Andreas Hinz²
 Harald Bailer³
 Norbert Grulke³
 Elmar Brähler²

Validation and Standardization of the „Questionnaire for Assessing Subjective Physical Well-Being“ by Kolip and Schmidt in a Representative German Sample

Zusammenfassung

Der „Fragebogen zur Erfassung des körperlichen Wohlbefindens“ (FEW-16, [1]) wurde in einer repräsentativen deutschen Bevölkerungsstichprobe (573 Befragte in Ostdeutschland und 1900 in Westdeutschland) eingesetzt. In der untersuchten nicht-klinischen Stichprobe scheint das mit dem FEW-16 operationalisierte Konstrukt „körperliches Wohlbefinden“ eindimensional zu sein. Da Frauen und Befragte mit zunehmendem Alter niedrigere Werte für „körperliches Wohlbefinden“ angeben, wurden nach Geschlecht und Altersgruppen differenzierte Normwerte erstellt. Zusammenhänge zwischen „körperlichem Wohlbefinden“ und dem Körperbild, erfasst mit dem „Fragebogen zum Körperbild“ (FKB-20 [10]), der Lebensqualität („EURO-HIS-QOL“ [11,12]) und Fragen nach Besorgtheit um die finanzielle Situation, die Familie und den Gesundheitszustand liefern Hinweise auf die Validität des Instrumentes.

Abstract

The „Questionnaire for Assessing Subjective Physical Well-Being“ by Kolip and Schmidt [1] is examined using data drawn from a nationally representative survey of 573 former East and 1900 former West Germans. In this non-clinical sample the construct „subjective physical well-being“ assessed by the „Questionnaire for Assessing Subjective Physical Well-Being“ seems to have just one dimension. As women and probands with growing age score lower for „subjective physical well-being“ a differentiated standardization was done for gender and age. Connections between „subjective physical well-being“ and body-image assessed by the „Body Image Questionnaire“ (FKB-20 [10]), quality of life („EURO-HIS-QOL“ [11,12]), and questions for concerns about financial situation, family and health give hints for validity of the questionnaire.

Key words

Subjective physical well-being · body-image · representative survey · standardization

Institutsangaben

¹ Universitätsklinikum Leipzig, Klinik für Psychotherapie und Psychosomatische Medizin

² Universitätsklinikum Leipzig, Selbstständige Abteilung für Medizinische Psychologie und Medizinische Soziologie

³ Universitätsklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie Ulm

Korrespondenzadresse

PD Dr. Cornelia Albani · Universitätsklinikum Leipzig · Klinik für Psychotherapie und Psychosomatische Medizin · Karl-Tauchnitz-Straße 25 · 04107 Leipzig · E-mail: Cornelia.Albani@medizin.uni-leipzig.de

Eingegangen: 18. November 2005 · **Angenommen:** 10. Januar 2006

Bibliografie

Psychother Psych Med 2006; 56: 172 – 181 © Georg Thieme Verlag KG Stuttgart · New York
 DOI 10.1055/s-2005-915467
 ISSN 0937-2032

Einleitung

Das Konstrukt „Subjektives Wohlbefinden“, das inhaltlich dem Konzept „Lebenszufriedenheit“ nahe liegt und zunehmende Bedeutung in der Gesundheitsforschung und Interventionspraxis gewonnen hat [1], ist nicht eindeutig definiert [2,3]. Becker [2] schlägt eine Unterscheidung zwischen aktuellem und habituellem Wohlbefinden vor. Aktuelles Wohlbefinden wird durch das momentane Erleben einer Person charakterisiert. Habituelles Wohlbefinden kennzeichnet hingegen das für eine Person typische Wohlbefinden i. S. von Urteilen über aggregierte Erfahrungen im Zeitraum von einigen Wochen. Strukturell beinhaltet sowohl aktuelles wie auch habituelles Wohlbefinden die Dimensionen physisches und psychisches Wohlbefinden.

Da der psychische Zustand (insbesondere Wohlbefinden), neben dem körperlichen Zustand und der Funktionalität als wichtige Kategorie von Gesundheit verstanden [4] und Wohlbefinden zunehmend als Indikator für die Beschreibung des Gesundheitszustandes und seiner Veränderung verwendet wird [1], ist die Operationalisierung von Wohlbefinden relevant. Umfassende Übersichten von Instrumenten zur Erfassung subjektiven Wohlbefindens finden sich bei Schumacher et al. [5] und Mayring [3] und zur Bestimmung körperlichen Wohlbefindens bei Frank [6]. Während zahlreiche Instrumente entweder nur das psychische Wohlbefinden, z.B. Befindlichkeit im Sinne affektiven Erlebens („Profile of Mood States“, POMS, [7]) oder lediglich den negativen Pol körperlichen Wohlbefindens, z.B. Funktionseinschränkungen („Nottingham Health Profile“, NHP, [8,9]) operationalisieren, dient der „Fragebogen zur Erfassung körperlichen Wohlbefindens“ (FEW-16, [1]) zur Erfassung des habituellen körperlichen Wohlbefindens Erwachsener, das nicht als die Abwesenheit von Krankheit, Schmerzen oder Funktionseinschränkungen definiert wird. Körperliches Wohlbefinden wird nicht als „Nullpunkt auf einer Missbehagensskala“ ([6] S. 71) verstanden, sondern als eigenständige Befindensqualität. Ausgehend von der Gesundheitsdefinition der WHO und dem Salutogenese-Konzept Antonovskys soll der FEW-16 den positiven Pol des Gesundheits-/Krankheitskontinuums operationalisieren und dabei verschiedene Dimensionen des habituellen körperlichen Wohlbefindens abdecken [1]. Jeweils vier Items bilden die Dimensionen „Belastbarkeit“, „Vitalität“, „Genussfähigkeit“ und „Innere Ruhe“. Das Instrument wurde an zwei Klinikstichproben von PatientInnen einer Rehabilitationsklinik entwickelt und an einer Studierendenstichprobe erprobt. Anhand einer Stichprobe von 193 PatientInnen mit chronischen Rückenschmerzen ergaben sich interne Konsistenzen (Cronbach's α) zwischen 0,82 und 0,90 und Validitätshinweise anhand von Zusammenhängen mit dem „Fragebogen zum Gesundheitszustand“ (SF-36, [14]) und einem Fragebogen zur Erfassung von Rückenschmerzen [1]. Bezüglich der Faktorenstruktur des Instrumentes berichten Kolip u. Schmidt [1] eine fünffaktorielle Struktur für die Vorversion des Instrumentes mit 25 Items. Durch Ausschluss der Items, die Nebenladungen auf anderen Faktoren oder die niedrigste Faktorenladung aufwiesen sowie der Items des ursprünglich fünften Faktors „Positives Körpergefühl“ entstand die endgültige Version des Instrumentes mit 16 Items und vier Dimensionen. An zwei klinischen und einer studentischen Stichprobe ($n = 41$) wurden Retestreliabilitätskoeffizienten (3 Wochen) von 0,55 („Genussfähigkeit“) bis 0,92 („Gesamtskala“, die von Kolip u. Schmidt [1] als Mittelwert der 16

Items bestimmt wurde) ermittelt [15]. Es ergaben sich in den untersuchten PatientInnenstichproben kaum Alters- und Geschlechtsunterschiede – lediglich auf der Skala „Innere Ruhe“ gaben Patienten höhere Werte an als Patientinnen.

Der FEW-16 wurde an klinischen Stichproben entwickelt und bisher noch nicht in einer repräsentativen Bevölkerungsstichprobe eingesetzt. Das Ziel der vorliegenden Arbeit liegt in der Überprüfung und Normierung des „Fragebogen zur Erfassung körperlichen Wohlbefindens“ an einer repräsentativen deutschen Bevölkerungsstichprobe. Bei der Überprüfung der faktoriellen Struktur des Fragebogens orientieren wir uns am Vorgehen der Autorinnen (Hauptkomponentenanalyse mit Varimax-Rotation, [1]).

Um Hinweise auf die Validität des „Fragebogen zur Erfassung körperlichen Wohlbefindens“ zu erhalten, werden Zusammenhänge mit dem „Fragebogen zum Körperbild“ (FKB-20, [10]) und dem Lebensqualitätsfragebogen „EURO-HIS-QOL“ [11,12] geprüft. Es wird erwartet, dass körperliches Wohlbefinden in positivem Zusammenhang mit Lebensqualität und „Vitaler Körperdynamik“ (FKB-20), aber in negativem Zusammenhang mit „Abnehmender Körperbewertung“ (FKB-20) steht. Des Weiteren werden Zusammenhänge zwischen Fragen nach der Besorgtheit um die finanzielle Situation, die Familie und den Gesundheitszustand und dem körperlichen Wohlbefinden untersucht, wofür negative Korrelationen, betragsmäßig am höchsten für Sorgen um den Gesundheitszustand, erwartet werden.

Stichprobe

Die Daten der vorliegenden Untersuchungen wurden im Herbst 2004 im Auftrag der Universität Leipzig von dem Meinungsforschungsinstitut USUMA Berlin im Rahmen einer bevölkerungsrepräsentativen Mehrthemenumfrage erhoben. Die in die Studie einbezogenen Personen wurden von geschulten Interviewern zu Hause aufgesucht und dort befragt (Face-to-face-Interview). Im Rahmen der Interviews bekamen die ProbandInnen Fragebogen zur selbstständigen Beantwortung vorgelegt; die Teilnahme erfolgte freiwillig. Jeder Befragte erhielt eine vom Interviewer unterschriebene Datenschutzerklärung. Die Zufallsauswahl der Haushalte erfolgte nach dem Random-Route-Verfahren. Die im Haushalt zu befragende Person wurde ebenfalls nach dem Zufallsprinzip ermittelt. Die Repräsentativität der Stichprobe konnte durch Ziehung von ADM (Arbeitskreis Deutsche Marktforschungsinstitute) – Stichproben [13] und durch Vergleiche mit den Angaben des Statistischen Bundesamtes gesichert werden.

In unserer Erhebung stellte die in Privathaushalten lebende deutsche Wohnbevölkerung im Alter ab 14 Jahren die Grundgesamtheit dar. Die Ausschöpfungsquote der Erhebung lag bei 62,3%. An der Untersuchung nahmen 2591 Personen im Alter von 14–99 Jahren teil. Wir beschränken uns hier auf diejenigen Befragten mit deutscher Staatsangehörigkeit ($n = 2473$). Angaben zu den soziodemografischen Merkmalen der ProbandInnen (573 Befragte in Ostdeutschland und 1900 in Westdeutschland) sind Tab. 1 zu entnehmen.

Tab. 1 Soziodemografische Merkmale der Stichprobe (absolute und relative Häufigkeiten in %)

gesamt (n = 2473)		
Geschlecht		
männlich	1171	47,4%
weiblich	1302	52,6%
Alter (Jahre)		
Mittelwert	48,1	
Standardabweichung	18,0	
Range	14 – 99	
Familienstand		
verheiratet, gemeinsam lebend	1299	52,5%
verheiratet, getrennt lebend	26	1,1%
ledig	587	23,7%
geschieden	258	10,4%
verwitwet	303	12,3%
Bildung		
ohne Abschluss	36	1,5%
Hauptschulabschluss (8. Klasse)	1112	45,0%
mittlere Reife/Realschule	678	27,4%
POS/10. Klasse	162	6,6%
Fachschule	70	2,8%
Abitur	177	7,2%
abgeschlossenes Hoch-/FH-Studium	171	6,9%
Schüler/in	67	2,7%
Erwerbstätigkeit		
vollzeitbeschäftigt (> 35 Stunden)	899	36,4%
teilzeitbeschäftigt (15 – 34 Stunden)	189	7,6%
teilzeitbeschäftigt (≤ 14 Stunden)	49	2,0%
Zivildienstleistende/Erziehungsurlaub ...	37	1,5%
Arbeitslose	168	6,8%
Rentner	754	30,5%
nicht berufstätig	185	7,5%
in Berufsausbildung	35	1,4%
in Schul-, Hochschulausbildung	157	6,4%
Haushaltseinkommen (netto, n = 2361)		
< 750 €/Monat	105	4,5%
750 bis 1250 €/Monat	507	21,5%
1250 bis 2000 €/Monat	911	38,6%
> 2000 €/Monat	838	35,5%

Methoden

„Fragebogen zur Erfassung des körperlichen Wohlbefindens“ (FEW-16) [1]

Mit dem Fragebogen werden vier Dimensionen körperlichen Wohlbefindens erfasst: „*Belastbarkeit*“ (z.B. „Ich bin körperlich belastbar.“), „*Vitalität*“ (z.B. „Ich wache morgens energiegeladener auf.“), „*Genussfähigkeit*“ (z.B. „Ich nehme mir Zeit, meinem Körper Gutes zu tun.“) und „*Innere Ruhe*“ (z.B. „Ich fühle mich innerlich im Gleichgewicht.“). Jeder Skala sind jeweils vier ausschließlich positiv formulierte Items zugeordnet, die auf einer sechsstufigen Skala (0 = „trifft überhaupt nicht zu“, 1 = „trifft kaum zu“, 2 = „trifft eher nicht zu“, 3 = „trifft eher zu“, 4 = „trifft überwiegend zu“, 5 = „trifft voll und ganz zu“) bewertet werden. Die Skalenwerte wurden als Mittelwerte der zugehörigen Items errechnet, wobei maximal ein Fehlwert je Skala durch den Skalenmittelwert ersetzt wurde. Wir berechneten den Gesamtwert als Mittelwert der vier Skalenwerte.

„Fragebogen zum Körperbild“ (FKB-20)

von Clement u. Löwe [10]

Der „Fragebogen zum Körperbild“ [10] besteht aus 20 Items, die auf einer fünfstufigen Antwortskala (1 = „trifft nicht zu“, 2 = „trifft kaum zu“, 3 = „trifft teilweise zu“, 4 = „trifft weitgehend zu“, 5 = „trifft vollständig zu“) beantwortet werden. Jeweils 10 Items werden zu einer Subskala aufaddiert (Wertebereich 10–50). Die Subskala „*Ablehnende Körperbewertung*“ soll körperzentrierte Störungen erfassen und fasst diejenigen Items zusammen, die eine Bewertung des eigenen Körpers beinhalten. Dabei wird einerseits die äußere Körpererscheinung beurteilt, andererseits wird das Gefühl der Stimmigkeit sowie das Wohlbefinden im eigenen Körper erfragt (z.B. Item 6 „Mir ist mein Körper oft lästig.“). Die Skala „*Vitale Körperdynamik*“ beinhaltet Items, die den energetischen und bewegungsbezogenen Aspekt des Körperbildes sowie körperintensive Aktivitäten (Tanzen, Sexualität) beschreiben und v.a. depressive Aspekte der Körperlichkeit erfassen.

Clement u. Löwe [10] ermittelten für die drei von ihnen untersuchten Stichproben (Medizin- und Sportstudierende, psychosomatische PatientInnen) Skaleninterkorrelationen zwischen – 0,29 und – 0,39 und interne Konsistenzen zwischen 0,73–0,91 für die Skala „*Ablehnende Körperbewertung*“ und 0,65–0,89 für die Skala „*Vitale Körperdynamik*“.

EURO-HIS-QOL [11,12]

Der EURO-HIS-QOL dient der Erfassung der allgemeinen Lebensqualität im psychologischen, physischen, sozialen und umweltbezogenen Bereich. Die 8 Items wurden aus den beiden Fragebogen WHO-QOL-100 [11,16] und WHO-QOL-BREF [17,18] ausgewählt. Sie werden auf einer fünfstufigen Skala (1 = „sehr schlecht“ bis 5 = „sehr gut“) für den Zeitraum der vergangenen 2 Wochen erhoben und bilden einen Summenscore. Umfangreiche Untersuchungen mit dem Fragebogen liefern Hinweise auf gute psychometrische Eigenschaften (Cronbach's α von 0,80 bei [12]).

Fragen nach Besorgtheit [19]

Die ProbandInnen wurden gebeten, ihre aktuelle Belastungssituation in drei Lebensbereichen auf einer vierstufigen Skala einzuschätzen: „Wie sehr machen Sie sich zurzeit Sorgen wegen: Ihrer finanziellen Situation, Ihrer Familie, Ihrer gesundheitlichen Situation?“ (1 = „überhaupt keine“, 2 = „eher wenig“, 3 = „eher viel“, 4 = „sehr große“).

In die vorliegende Auswertung wurden nur die Fragebogen einbezogen, in denen pro Skala maximal ein Item fehlte – dieses wurde ggf. durch den Skalenmittelwert ersetzt.

Die Daten wurden mithilfe des statistischen Softwarepakets SPSS für Windows 10.0 analysiert.

Ergebnisse

Deskriptive Statistik

In Tab. 2 sind Mittelwerte und Standardabweichungen der Items des FEW-16 dargestellt. In den Antworten wurde für alle Items die gesamte Spannweite von 0–5 ausgenutzt.

Tab. 2 Mittelwerte (M) und Standardabweichung (S) für die Items des FEW-16 (n = 2449 – 2458)

	M	S
1 Mein Körper ist robust.	3,44	1,17
2 Ich habe einen erholsamen Schlaf.	3,60	1,13
3 Mich kann kaum etwas aus der Ruhe bringen.	3,31	1,10
4 Ich wache morgens ausgeschlafen auf.	3,48	1,15
5 Mein Körper ist widerstandsfähig.	3,51	1,13
6 Ich fühle mich innerlich im Gleichgewicht.	3,57	1,09
7 Ich habe ein sicheres Gefühl für das, was meinem Körper gut tut.	3,66	1,00
8 Ich erlebe meinen Körper als leistungsfähig.	3,51	1,16
9 Nach dem Aufwachen bin ich ausgeruht.	3,53	1,17
10 Ich bin körperlich belastbar.	3,51	1,21
11 Ich nehme mir Zeit, meinem Körper Gutes zu tun.	3,50	1,08
12 Ich wache morgens energiegeladen auf.	3,25	1,23
13 Ich kann es mir körperlich richtig gut gehen lassen.	3,46	1,15
14 Ich habe ein gutes Gefühl für das, was mein Körper braucht.	3,65	1,01
15 Ich bin ruhig und gelassen.	3,54	1,06
16 Ich bin ausgeglichen.	3,55	1,07

M = Mittelwert (Range 0 – 5, niedrigere/höhere Scores = Ablehnung/stärkere Zustimmung); S = Standardabweichung

Faktorenstruktur des FEW-16

Die Hauptkomponentenanalyse führt zu einer einfaktoriellen Lösung, die 64,6% der Varianz aufklärt (Eigenwerteverlauf: 10,3 – 0,95 – 0,78 – 0,71 – 0,47 ...).

Unter Vorgabe von vier Faktoren ergeben sich nach orthogonaler Varimax-Rotation die in Tab. 3 dargestellten Faktorladungen (80% Varianzaufklärung). Alle Items laden am höchsten auf dem zugehörigen Faktor. Allerdings finden sich teilweise erhebliche Nebenladungen (bis zu 0,47) auf anderen Faktoren.

Die internen Konsistenzen der vier Skalen liegen zwischen 0,88 („Genussfähigkeit“) und 0,93 („Belastbarkeit“) und können insgesamt als gut bezeichnet werden (Tab. 4).

Tab. 3 FEW-16: Kommunalitäten und Faktorladungen (Hauptkomponentenanalyse mit der Vorgabe vier zu extrahierender Faktoren, Varimax-Rotation, Ladungen $\geq |0,30|$, n = 2410)

Item-Nr.	h ²	Faktoren			
		1	2	3	4
Belastbarkeit					
1	0,83	0,83			
10	0,79	0,75	0,30		
5	0,83	0,75	0,35		
8	0,83	0,73	0,31	0,35	
Vitalität					
4	0,80		0,80		0,32
9	0,77		0,77	0,31	
2	0,70	0,41	0,70		
12	0,67	0,37	0,67	0,35	
Genussfähigkeit					
11	0,76		0,32	0,76	
14	0,76	0,33		0,76	
7	0,62	0,47		0,62	
13	0,59	0,37	0,41	0,59	
Innere Ruhe					
15	0,77			0,36	0,77
16	0,76		0,30	0,37	0,76
3	0,72	0,37			0,72
6	0,50	0,46	0,34	0,39	0,50

h² = Kommunalität

Tab. 5 Interkorrelationen der Skalen des FEW-16

	2	3	4	Gesamtwert
Belastbarkeit (1)	0,75	0,75	0,74	0,90
Vitalität (2)		0,76	0,77	0,91
Genussfähigkeit (3)			0,77	0,90
innere Ruhe (4)				0,90

Spearman-Korrelationskoeffizienten, $p < 0,001$ für alle Korrelationen, zweiseitig, n = 2455 – 2457

Es zeigen sich hohe Interkorrelationen zwischen den Skalen und mit dem Gesamtwert (Tab. 5).

Tab. 4 Skalenkennwerte des FEW-16 (n = 2473)

	M (S)	Cronbach's α	Range der part-whole Korrelationen *	Schiefe	Exzess
Belastbarkeit	3,49 (1,06)	0,93	0,82 – 0,84	– 0,79	0,46
Vitalität	3,47 (1,05)	0,92	0,78 – 0,86	– 0,79	0,48
Genussfähigkeit	3,57 (0,91)	0,88	0,70 – 0,79	– 0,64	0,61
Innere Ruhe	3,49 (0,95)	0,90	0,71 – 0,84	– 0,63	0,56
Gesamtwert	3,51 (0,90)	0,96	0,68 – 0,82	– 0,63	0,47

* jeweils für die vier der Skala zugehörigen Items

Tab. 6 Mittelwerte (Streuungen) für den FEW-16-Gesamtwert und die FEW-16-Skalenwerte in verschiedenen Subgruppen

	FEW-16				
	Gesamtwert	Belastbarkeit	Vitalität	Genussfähigkeit	innere Ruhe
	M (S)	M (S)	M (S)	M (S)	M (S)
gesamt (n = 2458)	3,51	3,49	3,47	3,57	3,49
	(0,90)	(1,06)	(1,05)	(0,91)	(0,95)
Geschlecht					
männlich (n = 1163)	3,65 (0,88)	3,66 (1,04)	3,63 (0,99)	3,65 (0,89)	3,65 (0,91)
weiblich (n = 1295)	3,38 (0,89)	3,34 (1,05)	3,32 (1,09)	3,49 (0,92)	3,36 (0,96)
Wohnort					
Ostdeutschland (n = 570)	3,49 (0,93)	3,45 (1,11)	3,43 (1,09)	3,59 (0,96)	3,49 (0,96)
Westdeutschland (n = 1888)	3,51 (0,89)	3,50 (1,05)	3,48 (1,04)	3,56 (0,89)	3,50 (0,95)
Bildung					
Schule (n = 2114)	3,49 (0,91)	3,45 (1,08)	3,45 (1,06)	3,55 (0,91)	3,49 (0,95)
Abitur (n = 344)	3,62 (0,84)	3,73 (0,94)	3,54 (1,02)	3,69 (0,86)	3,53 (0,97)
Alter					
bis 24 Jahre (n = 276)	3,81 (0,88)	3,92 (0,93)	3,75 (1,14)	3,85 (0,92)	3,73 (0,97)
25 – 34 Jahre (n = 348)	3,79 (0,84)	3,93 (0,85)	3,74 (1,03)	3,80 (0,92)	3,70 (0,94)
35 – 44 Jahre (n = 500)	3,58 (0,87)	3,66 (0,98)	3,57 (0,99)	3,60 (0,91)	3,51 (0,97)
45 – 54 Jahre (n = 393)	3,55 (0,86)	3,62 (0,96)	3,48 (1,06)	3,60 (0,87)	3,51 (0,96)
55 – 64 Jahre (n = 394)	3,41 (0,83)	3,34 (0,97)	3,40 (0,94)	3,48 (0,82)	3,42 (0,88)
65 – 74 Jahre (n = 366)	3,18 (0,89)	2,96 (1,11)	3,15 (1,03)	3,32 (0,86)	3,30 (0,89)
ab 75 Jahre (n = 181)	3,02 (0,92)	2,64 (1,16)	2,97 (1,10)	3,22 (0,95)	3,26 (0,96)

Tab. 7 Zusammenhänge zwischen körperlichem Wohlbefinden (FEW-16) und Körperbild (FKB-20), Besorgtheit und Lebensqualität (EURO-HIS-QOL)

	M	FEW-16				
	(S)	Belastbarkeit	Vitalität	Genussfähigkeit	innere Ruhe	Gesamtwert
FKB-20						
Ablehnende Körperbewertung	18,76 (6,21)	– 0,44	– 0,38	– 0,47	– 0,42	– 0,47
Vitale Körperdynamik	34,03 (8,31)	0,75	0,61	0,60	0,56	0,70
„Sorgen um“						
finanzielle Situation	2,04 (0,92)	– 0,08	– 0,19	– 0,18	– 0,20	– 0,18
Familie	1,85 (0,86)	– 0,18	– 0,25	– 0,22	– 0,27	– 0,25
gesundheitliche Situation	1,94 (0,87)	– 0,56	– 0,47	– 0,41	– 0,42	– 0,52
EURO-HIS-QOL						
Summenwert	30,98 (4,73)	0,62	0,58	0,59	0,56	0,65

Spearman-Korrelationskoeffizienten, $p < 0,001$ für alle Korrelationen, zweiseitig, $n = 2440 - 2453$

Tab. 8a FEW-16: Prozentrangnormen für Frauen getrennt nach Altersgruppen

Skalenwert	Belastbarkeit							Vitalität							Genussfähigkeit									
	gesamt	bis 24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	ab 75	gesamt	bis 24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	ab 75	gesamt	bis 24	25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	ab 75
	n = 1295	n = 135	n = 188	n = 277	n = 210	n = 195	n = 175	n = 115	n = 1295	n = 135	n = 188	n = 277	n = 210	n = 195	n = 175	n = 115	n = 1294	n = 134	n = 188	n = 277	n = 210	n = 195	n = 175	n = 115
0,00	0,8		0,5	1,1	0,5		1,7	2,6	0,8		2,1	0,4	1,4		0,6	1,7	0,2						0,6	0,9
0,25	1,2		0,5	1,4	0,5	0,5	2,3	4,3	1,5	1,5	2,7	1,4	1,9		1,1	2,6	0,6	0,7	0,5	1,1			1,1	0,9
0,50	1,7		0,5	1,8	1,0	1,0	3,4	5,2	2,4	2,2	3,2	2,5	2,9	0,5	2,9	2,6	0,7	0,7	0,5	1,1		0,5	1,1	0,9
0,75	2,6		1,1	2,2	1,0	1,0	6,9	8,7	3,0	3,0	3,7	3,2	3,3	1,0	2,9	4,3	0,9	0,7	1,6	1,4		0,5	1,1	0,9
1,00	4,4	0,7	1,6	2,5	2,9	3,1	10,3	13,9	4,9	3,0	4,8	3,6	6,7	3,1	7,4	7,0	1,9	0,7	1,6	1,8	1,0	1,0	4,0	3,5
1,25	5,6	1,5	2,1	2,9	3,8	4,1	12,6	18,3	6,6	7,4	5,3	4,3	7,1	4,6	8,0	13,0	2,5	2,2	1,6	2,5	1,4	1,5	5,1	3,5
1,50	7,4	2,2	4,3	3,6	4,8	5,6	16,6	21,7	7,9	8,1	5,3	6,5	8,1	5,1	10,9	14,8	3,6	2,2	3,7	4,0	2,4	2,1	5,7	6,1
1,75	9,2	3,7	4,8	4,7	6,2	8,7	17,7	27,0	10,3	8,9	6,9	7,6	10,0	8,2	16,0	19,1	4,7	3,0	5,3	5,4	4,3	2,6	6,3	6,1
2,00	13,1	5,2	6,4	7,2	9,5	13,3	26,3	33,0	15,4	14,8	12,2	11,6	14,3	11,8	25,1	23,5	6,9	5,2	8,0	6,9	5,7	5,1	8,6	9,6
2,25	17,1	7,4	6,9	10,1	12,9	19,5	33,1	40,9	17,6	18,5	13,3	12,6	18,1	13,3	28,6	25,2	10,1	7,5	12,2	9,7	7,6	8,7	12,6	13,9
2,50	21,6	11,1	9,0	13,4	14,8	26,7	40,0	50,4	21,2	20,0	16,5	16,2	21,4	15,9	34,3	31,3	15,7	12,7	18,1	14,8	12,4	12,8	19,4	22,6
2,75	27,4	19,3	14,4	18,1	18,6	33,3	46,3	58,3	27,9	24,4	20,2	22,0	25,7	28,2	40,0	43,5	21,7	19,4	22,3	18,8	16,2	21,0	29,7	29,6
3,00	38,4	28,1	22,9	28,9	28,1	47,7	60,0	68,7	39,8	31,1	29,3	34,7	38,1	44,1	53,1	54,8	35,1	29,9	31,4	28,9	27,1	41,5	46,9	47,8
3,25	46,8	38,5	29,8	34,3	37,1	59,5	70,3	74,8	46,6	36,3	36,7	41,9	44,3	50,3	58,9	66,1	42,4	36,6	36,7	35,7	36,2	48,2	56,0	55,7
3,50	54,5	44,4	38,3	44,0	45,2	64,6	76,6	84,3	54,7	41,5	46,3	48,0	52,9	59,5	68,0	75,7	51,4	45,5	45,2	45,8	46,2	58,5	63,4	60,9
3,75	63,0	54,8	47,3	53,8	58,1	70,3	82,3	87,8	63,9	53,3	54,3	58,5	61,9	69,7	76,6	80,0	60,6	50,7	53,2	53,8	58,1	69,2	70,9	74,8
4,00	79,8	67,4	64,9	74,4	82,4	87,7	93,1	93,9	78,8	61,5	70,2	76,9	80,5	85,1	89,1	87,8	76,7	64,2	67,6	75,1	76,7	81,5	87,4	86,1
4,25	85,6	74,1	73,4	82,3	87,1	92,3	97,7	93,9	85,4	68,9	76,6	85,9	87,1	92,8	93,7	89,6	84,4	73,9	75,0	84,8	83,8	87,7	94,9	90,4
4,50	90,7	82,2	85,6	89,5	90,5	94,4	97,7	95,7	90,5	77,8	82,4	90,6	91,4	96,9	97,7	94,8	89,5	83,6	83,5	89,2	88,1	92,8	96,0	93,9
4,75	94,1	90,4	91,5	93,5	92,4	96,4	98,3	97,4	93,5	84,4	89,9	93,5	92,4	97,9	98,3	97,4	93,2	88,8	88,8	92,1	92,9	96,4	98,3	95,7
5,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tab. 8b FEW-16: Prozentrangnormen für Frauen getrennt nach Altersgruppen

Skalenwert	innere Ruhe								FEW-Gesamtwert							
	gesamt n = 1295	bis 24 n = 135	25–34 n = 188	35–44 n = 277	45–54 n = 210	55–64 n = 195	65–74 n = 175	ab 75 n = 115	gesamt n = 1294	bis 24 n = 134	25–34 n = 188	35–44 n = 277	45–54 n = 210	55–64 n = 195	65–74 n = 175	ab 75 n = 115
0,00	0,5		1,1	0,7	1,0		0,6		0,1							0,6
0,25	0,8		1,1	1,4	1,0		1,1	0,9	0,2						1,1	0,9
0,50	1,2	0,7	1,1	1,8	1,4		1,1	1,7	0,7	0,7	1,1	0,7	0,5		1,1	0,9
0,75	1,6	1,5	1,1	2,2	1,9	0,5	1,7	2,6	0,9	0,7	1,1	1,1	0,5		1,1	1,7
1,00	2,5	1,5	2,1	2,9	2,4	1,0	4,0	4,3	1,5	0,7	1,1	1,4	1,0	0,5	2,9	4,3
1,25	3,6	3,7	2,7	3,6	3,3	2,6	4,6	6,1	2,5	0,7	1,6	2,2	1,0	1,5	5,7	6,1
1,50	4,9	4,4	4,3	6,1	3,8	3,1	5,7	7,0	3,8	0,7	2,7	3,2	2,9	3,1	6,3	9,6
1,75	6,7	5,9	4,8	7,2	5,2	5,6	9,7	9,6	5,3	1,5	3,7	5,1	3,8	3,6	8,6	13,0
2,00	10,3	8,1	9,6	12,6	9,0	8,2	12,6	11,3	7,7	3,0	6,4	7,9	5,2	6,2	12,0	14,8
2,25	13,6	14,1	11,7	15,2	12,4	12,3	15,4	13,9	10,9	4,5	9,0	9,7	8,1	9,2	18,9	20,0
2,50	18,8	17,8	18,1	18,8	16,2	17,4	23,4	21,7	15,5	13,4	10,1	12,6	12,9	15,9	22,9	26,1
2,75	27,0	20,7	25,5	24,9	26,7	28,7	30,9	33,9	21,9	18,7	16,5	16,2	18,6	20,5	36,6	33,9
3,00	39,7	31,9	36,7	36,8	38,6	42,6	45,7	48,7	33,3	26,9	27,1	27,1	26,7	38,5	48,0	47,0
3,25	48,0	40,0	45,2	43,0	45,2	53,8	56,0	56,5	43,2	32,1	31,9	36,1	40,0	50,3	57,7	63,5
3,50	57,0	52,6	52,7	50,2	55,7	63,1	65,1	65,2	53,0	44,0	41,0	44,8	48,1	62,1	67,4	74,8
3,75	67,9	62,2	63,8	65,3	66,2	72,8	74,9	71,3	62,8	53,7	51,6	56,3	61,0	68,2	76,0	80,9
4,00	81,1	68,1	74,5	80,9	81,4	87,7	89,7	82,6	78,4	64,2	72,3	74,7	76,7	83,6	89,7	91,3
4,25	86,2	77,0	79,3	86,6	85,7	91,8	93,7	87,0	86,3	76,9	77,7	84,1	86,7	91,8	95,4	93,0
4,50	90,5	85,2	85,1	90,3	90,5	94,4	96,6	90,4	91,0	82,1	84,0	90,6	91,4	95,4	97,7	95,7
4,75	94,5	90,4	90,4	94,6	94,3	97,4	98,9	94,8	94,7	89,6	90,4	94,2	94,3	97,9	98,9	97,4
5,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Einfluss soziodemografischer Faktoren auf den FEW-16

In einer dreifaktoriellen Kovarianzanalyse mit den Faktoren Geschlecht, aktueller Wohnort (Ost- oder Westdeutschland) und Bildungsgrad (Schulabschluss mit Haupt-, Volksschule, mittlere Reife vs. Hochschulreife) mit Alter als Kovariate resultieren Alterseffekte und signifikante Haupteffekte für den Faktor Geschlecht für alle Skalen und den Gesamtwert ($F > 56$, mit $df = 1$ und $df = 2446 - 2449$, p für alle F-Tests $< 0,005$).

Frauen geben niedrigere Werte für körperliches Wohlbefinden an als Männer, ebenso sinkt das körperliche Wohlbefinden mit zunehmendem Alter bei allen ProbandInnen (Tab. 6). Vor diesem Hintergrund wurden nach Geschlecht und Altersgruppen differenzierte Normtabellen erstellt (Tab. 8a u. b u. 9a u. b).

Zusammenhänge zwischen körperlichem Wohlbefinden, Körperbild, Lebensqualität und Besorgtheit

Es bestätigen sich die erwarteten deutlichen positiven Zusammenhänge zwischen körperlichem Wohlbefinden, Lebensqualität und der Skala „Vitale Körperdynamik“ des „Fragebogen zum Körperbild“ (Tab. 7). Mit der Skala „Ablehnende Körperdynamik“ des FKB-20 zeigen sich die erwarteten negativen Zusammenhänge, die aber betragsmäßig niedrig ausfallen.

Auch hinsichtlich der Fragen nach Besorgtheit finden sich die vermuteten negativen Zusammenhänge mit dem körperlichen Wohlbefinden, am deutlichsten für „Sorgen um die gesundheitliche Situation“.

Diskussion

Die vorliegende Untersuchung erfüllt die von Kolip u. Schmidt [1] erhobene Forderung nach einer psychometrischen Überprüfung des FEW-16 in einer nichtklinischen Stichprobe, wobei wir methodisch dem Vorgehen der Autorinnen folgten.

Kolip u. Schmidt [1] ermittelten in ihrer Analyse an einer klinischen Stichprobe vier Faktoren. Legt man das Kaiser-Kriterium (Eigenwert > 1) zur Bestimmung der Anzahl zu extrahierender Faktoren zugrunde, resultierte die in der vorliegenden nichtklinischen Stichprobe durchgeführte Hauptkomponentenanalyse in einer einfaktoriellen Lösung, die 64,6% der Varianz aufklärt. In einer erzwungenen vierfaktoriellen Lösung (s. Tab. 3) laden sämtliche Items maximal auf den von Kolip u. Schmidt [1] beschriebenen Skalen. Die von den Autoren berichteten Skaleninterkorrelationen von 0,46–0,63 werden in der vorliegenden Untersuchung deutlich überschritten (0,74–0,77).

Im nichtklinischen Kontext scheint das mit dem FEW-16 operationalisierte Konstrukt „körperliches Wohlbefinden“ eindimensional zu sein, sodass eine Differenzierung nach vier Subskalen möglicherweise nur für spezifische Fragestellungen einen zusätzlichen Informationsgewinn beinhaltet. In der Regel dürfte bei nichtklinischen Stichproben die Angabe eines Gesamtwertes genügen. Auch die zur Validierung eingesetzten Fragebogen FKB-20 und EURO-HIS-QOL liefern keine Hinweise auf eine differenzielle Bedeutung der Subskalen des FEW-16. Die Korrelationskoeffizienten zwischen den vier FEW-16-Subskalen und dem FEW-16-Gesamtwert mit jeweils einer der Validierungsskalen unterscheiden sich nicht wesentlich (Tab. 7). Wir konzentrie-

Tab. 9a Prozentrangnormen für den FEW-16 für Männer getrennt nach Altersgruppen

Skalenwert	Belastbarkeit							Vitalität							Genussfähigkeit									
	gesamt		25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	ab 75	gesamt		25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	ab 75	gesamt		25–34	35–44	45–54	55–64	65–74	ab 75
	n = 1163	n = 141	n = 160	n = 223	n = 183	n = 199	n = 191	n = 66	n = 1162	n = 141	n = 160	n = 223	n = 183	n = 199	n = 190	n = 66	n = 1161	n = 141	n = 159	n = 223	n = 183	n = 199	n = 190	n = 66
0,00	0,5			0,9		0,5	1,0	1,5	0,3			0,4		0,5		1,5	0,3	0,7				0,5		1,5
0,25	0,6			0,9		0,5	1,0	3,0	0,4	0,7		0,4		0,5		3,0	0,3	0,7				0,5		1,5
0,50	1,1			0,9		1,0	3,1	4,5	0,9	1,4		0,9		1,5	0,5	4,5	0,3	0,7				0,5	0,5	1,5
0,75	1,8			1,3	1,1	1,5	4,2	7,6	1,2	1,4		0,9	0,5	2,5	0,5	4,5	0,5	0,7		0,4	0,5	0,5	0,5	1,5
1,00	3,0	0,7		1,8	2,2	3,5	5,8	12,1	2,2	1,4	1,3	1,8	1,1	3,0	2,1	7,6	0,9	0,7	0,6	0,4	0,5	1,5	1,1	3,0
1,25	3,9	0,7	0,6	2,7	3,3	4,5	6,8	13,6	3,4	2,1	2,5	2,2	2,7	4,5	4,2	9,1	1,6	0,7	0,6	0,9	2,7	1,5	2,1	3,0
1,50	4,5	0,7	0,6	3,1	3,3	4,5	8,4	18,2	4,1	2,8	2,5	2,7	3,8	5,5	5,3	9,1	2,5	0,7	1,3	1,8	3,8	3,0	2,6	6,1
1,75	6,4	1,4	0,6	5,8	3,8	6,5	13,1	19,7	5,8	5,7	3,8	3,1	6,6	6,5	6,3	13,6	4,6	0,7	1,3	4,5	6,0	5,5	5,3	12,1
2,00	9,8	2,1	1,3	8,1	7,7	8,5	21,5	28,8	8,7	7,1	4,4	7,2	8,7	9,0	12,1	16,7	6,0	2,1	1,9	7,6	7,1	6,5	5,8	15,2
2,25	12,0	2,8	1,9	9,9	10,4	10,6	24,6	34,8	11,5	9,9	6,3	9,4	10,4	12,1	17,9	18,2	8,0	2,8	3,1	8,1	9,3	9,0	9,5	19,7
2,50	15,2	6,4	3,8	11,7	14,8	14,6	29,3	36,4	14,8	12,8	7,5	10,8	15,3	16,6	22,1	22,7	11,4	4,3	4,4	12,6	14,2	11,1	13,7	25,8
2,75	18,7	9,9	4,4	16,1	17,5	18,6	34,0	39,4	19,5	15,6	8,1	17,5	19,1	18,6	30,5	34,8	16,8	9,9	7,5	18,4	18,6	14,6	23,7	30,3
3,00	27,7	16,3	7,5	23,3	24,6	32,7	46,1	56,1	27,5	20,6	12,5	25,6	26,2	29,6	38,4	51,5	26,6	17,0	13,8	28,3	29,0	24,6	35,3	47,0
3,25	33,1	19,9	11,3	28,3	27,3	39,2	55,5	63,6	34,7	28,4	21,9	29,1	33,3	37,2	48,9	53,0	34,9	23,4	17,6	36,8	35,0	36,2	46,3	57,6
3,50	40,1	26,2	20,6	34,1	32,2	49,7	61,8	66,7	41,2	34,8	26,3	35,0	37,7	45,2	57,4	63,6	43,7	31,9	20,8	44,4	43,7	48,2	58,9	63,6
3,75	48,9	31,9	27,5	42,6	42,1	60,3	70,2	81,8	52,0	39,0	33,8	46,2	52,5	56,3	70,5	75,8	53,8	40,4	32,1	53,4	53,0	61,3	69,5	71,2
4,00	66,8	44,0	48,8	61,9	65,0	77,9	84,3	97,0	70,1	50,4	56,9	70,4	68,9	76,4	83,2	90,9	71,3	53,2	54,7	70,0	72,7	81,4	83,2	86,4
4,25	74,2	47,5	62,5	71,7	74,9	82,9	89,0	97,0	77,0	57,4	66,3	77,1	75,4	84,4	87,9	95,5	80,2	58,9	66,0	80,3	85,2	88,4	90,5	90,9
4,50	80,6	57,4	68,8	78,9	82,5	88,4	93,7	97,0	83,5	66,7	76,9	83,4	82,0	91,5	90,0	97,0	85,9	67,4	78,0	85,2	89,1	92,5	94,2	93,9
4,75	85,8	67,4	78,8	85,7	85,2	92,5	95,3	97,0	88,6	75,2	84,4	88,8	89,6	93,5	92,6	97,0	89,7	78,7	84,9	88,8	90,7	93,5	95,3	97,0
5,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

Tab. 9b Prozentrangnormen für den FEW-16 für Männer getrennt nach Altersgruppen

Skalenwert	innere Ruhe								FEW-Gesamtwert							
	gesamt n = 1162	bis 24 n = 141	25–34 n = 160	35–44 n = 223	45–54 n = 183	55–64 n = 199	65–74 n = 190	ab 75 n = 66	gesamt n = 1161	bis 24 n = 141	25–34 n = 159	35–44 n = 223	45–54 n = 183	55–64 n = 199	65–74 n = 190	ab 75 n = 66
0,00	0,3	0,7				0,5	0,5		0,1					0,5		
0,25	0,3	0,7			0,5	0,5	0,5		0,1					0,5		
0,50	0,3	0,7			0,5	0,5	0,5		0,3	0,7				0,5		1,5
0,75	0,5	0,7	0,6		0,5	1,0	0,5		0,4	0,7		0,4		0,5	0,5	1,5
1,00	1,3	0,7	0,6	0,4	2,2	2,5	1,6		0,9	0,7		0,4	0,5	1,5	1,6	1,5
1,25	1,8	0,7	1,9	0,9	2,7	2,5	2,1	1,5	1,7	0,7	0,6	1,8	1,1	3,5	1,6	3,0
1,50	2,8	0,7	1,9	3,1	3,8	4,0	2,1	3,0	2,4	0,7	1,3	1,8	2,7	3,5	2,6	6,1
1,75	3,9	1,4	1,9	4,0	5,5	4,5	3,7	7,6	3,5	0,7	1,9	2,2	3,8	5,0	4,7	9,1
2,00	6,5	3,5	3,8	7,6	8,2	7,0	5,8	10,6	5,1	1,4	1,9	4,9	6,0	6,0	6,3	12,1
2,25	9,0	6,4	5,0	9,4	10,4	11,1	9,5	12,1	7,8	2,1	2,5	6,7	8,7	8,0	13,2	18,2
2,50	11,6	8,5	5,6	12,6	11,5	12,1	14,7	19,7	10,9	5,0	3,1	9,9	10,4	12,1	18,9	21,2
2,75	17,7	10,6	7,5	18,8	20,2	18,1	24,2	27,3	15,0	8,5	5,0	13,9	17,5	13,6	23,7	28,8
3,00	28,1	19,9	11,9	28,3	26,8	30,2	39,5	48,5	22,9	14,2	7,5	21,1	23,0	26,1	32,6	47,0
3,25	35,1	27,7	16,9	34,5	35,5	39,7	44,7	54,5	30,1	20,6	12,6	27,8	28,4	32,2	44,7	56,1
3,50	43,7	36,2	25,0	42,2	42,6	47,2	59,5	57,6	38,8	28,4	18,9	36,3	37,7	41,2	56,8	60,6
3,75	54,2	44,7	36,9	52,5	52,5	61,3	67,4	68,2	49,4	34,0	27,0	47,1	47,5	56,3	67,4	75,8
4,00	70,7	56,7	56,3	70,0	70,5	77,9	82,6	83,3	67,7	50,4	49,7	63,7	66,7	76,4	84,2	90,9
4,25	78,6	63,1	67,5	79,4	78,1	83,9	89,5	89,4	77,1	56,7	64,2	76,7	76,5	83,9	90,0	97,0
4,50	84,8	70,2	81,3	85,2	83,6	87,9	91,6	97,0	83,6	63,8	78,0	83,9	81,4	90,5	93,2	97,0
4,75	90,2	81,6	86,3	90,1	91,3	92,0	94,7	97,0	90,8	78,7	87,4	90,6	91,8	96,0	94,2	97,0
5,00	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

ren die weiteren Überlegungen deshalb auf den FEW-16-Gesamtwert. Sollte sich die in dieser Untersuchung ermittelte Eindimensionalität des Instrumentes bestätigen, wäre die Entwicklung einer anwendungsökonomischeren Kurzform des FEW-16 erwägenswert.

Die von Kolip u. Schmidt [1] intendierte Geschlechts- und Altersunabhängigkeit des Fragebogens [15] ließ sich in der vorliegenden Stichprobe nicht bestätigen. Anders als in der Klinikstichprobe der Autorinnen, in der sich nur auf der Skala „*Innere Ruhe*“ für Männer höhere Werte, aber keine Altersunterschiede fanden, ergaben sich in der vorliegenden Untersuchung deutliche Geschlechts- und Alterseffekte für alle Skalen. Deshalb werden differenzierte alters- und geschlechtsspezifische Vergleichswerte berichtet. Diese Normwerte erlauben es, die in klinischen Stichproben erhobenen Werte bezogen auf die Normalpopulation einzuordnen.

Im Hinblick auf die Konstruktvalidierung ergaben sich wie erwartet negative Korrelationen mit der Skala „*Ablehnende Körperbewertung*“ des FKB-20 und positive mit der Skala „*Vitale Körperdynamik*“ (Tab. 7). Die beitragsmäßig höheren Zusammenhänge der FEW-Skalen mit der Skala „*Vitale Körperdynamik*“ des FKB-20 (0,56–0,75) als mit der Skala „*Ablehnende Körperbewertung*“ (0,38–0,47) liefern einen Hinweis auf die diskriminante Validität des FEW-16: Das körperliche Wohlbefinden wird besser durch die körperlichen, gesundheitsbezogenen und dynamischen Aspekte des Körperbildes (Skala „*Vitale Körperdynamik*“ des FKB-20) repräsentiert als durch die eher kognitiven Bewertungen des eigenen Körpers, die sich eher auf die Körpererscheinung

als auf die Gesundheit beziehen (Skala „*Ablehnende Körperbewertung*“ des FKB-20).

Der FEW-Gesamtwert korreliert mit der Skala „*Ablehnende Körperbewertung*“ des FKB-20 mit –0,47 und mit der Skala „*Vitale Körperdynamik*“ des FKB-20 mit 0,70. Dieser deutliche betragsmäßige Unterschied lässt sich möglicherweise dadurch erklären, dass die Skala „*Ablehnende Körperbewertung*“ eher kognitiv-bewertende Aspekte der äußeren Körpererscheinung erfasst [10] und die Mehrzahl der Items negative Aspekte betonen (körperliche Unvollkommenheit, Ekel, unzufrieden mit Figur, körperliche Mängel etc.). Demgegenüber sind die Items der Skala „*Vitale Körperdynamik*“ ebenso wie die des FEW-16 positiv formuliert.

Auch die Ergebnisse bezüglich der Fragen nach der Besorgtheit deuten auf die diskriminante Validität des FEW-16 hin. Für die Frage nach „*Sorgen um die gesundheitliche Situation*“ findet sich ein deutlicher korrelativer Zusammenhang ($r=0,52$) mit dem Gesamtwert des FEW-16. Demgegenüber ist das körperliche Wohlbefinden weniger mit der Besorgtheit um die finanzielle und familiäre Situation assoziiert.

Körperliches Wohlbefinden und Lebensqualität weisen ebenfalls erwartungsgemäß substantielle Korrelationen auf. Die Korrelation des FEW-16-Gesamtwertes mit dem Summenwert des EURO-HIS-QOL ($r=0,65$) weist zum einen auf die Konstruktvalidität des FEW-16 hin. Andererseits erfasst der EURO-HIS-QOL nicht nur körperliche Lebensqualität, sondern beansprucht, auch psychische und andere Bereiche von Lebensqualität abzubilden. Die beträchtliche Korrelation zwischen dem FEW-16-Gesamtwert

und dem Summenwert des EURO-HIS-QOL deutet allerdings auch darauf hin, dass mit dem FEW-16 wahrscheinlich neben Aspekten des körperlichen Wohlbefindens auch andere Aspekte von Wohlbefinden erfasst werden.

Die Autoren des FEW-16 bemängelten, dass bisher in der gesundheitspsychologischen Forschung v.a. psychisches, nicht aber körperliches Wohlbefinden erfasst wird [1]. Mit dem FEW-16 soll deshalb primär körperliches Wohlbefinden (explizit abgegrenzt von psychischem Wohlbefinden) erfasst werden (allerdings beinhalten einige Items durchaus psychische Aspekte von Wohlbefinden, z.B. Item 6 „Ich fühle mich innerlich im Gleichgewicht.“, Item 15 „Ich bin ruhig und gelassen.“ oder Items 16 „Ich bin ausgeglichen.“). Die vorliegenden Ergebnisse in einer nichtklinischen Stichprobe deuten aber darauf hin, dass diese Trennung mit dem FEW-16 nur eingeschränkt möglich ist, wobei die Stichprobenabhängigkeit der vorliegenden Ergebnisse beachtet werden muss und weitere Untersuchungen mit dem Instrument an klinischen und nichtklinischen Stichproben notwendig sind.

Fazit für die Praxis

Der „Fragebogen zur Erfassung des körperlichen Wohlbefindens“ (FEW-16, [1]) ermöglicht anhand der Dimensionen „Belastbarkeit“, „Vitalität“, „Genussfähigkeit“ und „Innere Ruhe“ die Erfassung körperbezogenen Wohlbefindens. In der vorliegenden nichtklinischen Stichprobe scheint das untersuchte Konstrukt eindimensional zu sein, sodass eine Differenzierung nach vier Subskalen möglicherweise nur für spezifische Fragestellungen einen zusätzlichen Informationsgewinn beinhaltet. Die testtheoretischen Kennwerte können als zufrieden stellend gelten und ergaben Hinweise auf die Validität des Instrumentes. Für den Fragebogen liegen jetzt auch Normwerte einer nichtklinischen repräsentativen deutschen Bevölkerungsstichprobe vor.

Literatur

- ¹ Kolip P, Schmidt B. Der Fragebogen zur Erfassung körperlichen Wohlbefindens. Zeitschrift für Gesundheitspsychologie 1999; 7: 77–87
- ² Becker P. Theoretische Grundlagen. In: Abele A, Becker P (Hrsg): Wohlbefinden. Theorie, Empirie, Diagnostik. Weinheim: Juventa, 1991: 13–50
- ³ Mayring P. Die Erfassung subjektiven Wohlbefindens. In: Abele A, Becker P (Hrsg): Wohlbefinden. Theorie, Empirie, Diagnostik. Weinheim: Juventa, 1991: 51–70
- ⁴ Schmidt L. Zur Dimensionalität von Gesundheit (und Krankheit). Zeitschrift für Gesundheitspsychologie 1998; 6: 161–178
- ⁵ Schumacher J, Klaiberg A, Brähler E. Diagnostische Verfahren zu Lebensqualität und Wohlbefinden. Göttingen: Hogrefe, 2003
- ⁶ Frank R. Körperliches Wohlbefinden. In: Abele A, Becker P (Hrsg): Wohlbefinden. Theorie, Empirie, Diagnostik. Weinheim: Juventa, 1991: 71–95
- ⁷ McNair D, Lorr M, Droppleman L. POMS Profile of Mood States. Ein Verfahren zur Messung von Stimmungszuständen. In: Collegium Internationale Psychiatricae Sclorum (CIPS) (Hrsg): Internationale Skalen für Psychiatrie. Weinheim: Beltz Test Gesellschaft, 1981
- ⁸ Hunt SM, McEwen J, McKenna SP. Nottingham Health Profile. Measuring Health status. London: Croom Helm, 1986
- ⁹ Hinz A, Klaiberg A, Schumacher J, Brähler E. Zur psychometrischen Qualität des Lebensqualitätsfragebogens Nottingham Health Profile (NHP) in der Allgemeinbevölkerung. Psychother Med Psychol 2003; 53: 353–358
- ¹⁰ Clement U, Löwe B. Fragebogen zum Körperbild (FKB-20). Göttingen, Bern, Toronto, Seattle: Hogrefe, 1996
- ¹¹ Power M, Bullinger M, Harper A, Group TW. The World Health Organization WHO-QOL-100: tests of the universality of quality of life in fifteen different cultural groups world-wide. Health Psychology 1998; 18: 495–505
- ¹² Schmidt S, Power M, Bullinger M, Nosikov A. Conceptual interrelationship between health indicators and quality of life: Results from the cross-cultural analysis of the Eurohis field study. Clinical Psychology and Psychotherapy 2005; 12: 28–50
- ¹³ Koch A. AMD-Design und Einwohnermelderegister-Stichprobe. Stichproben bei mündlichen Bevölkerungsumfragen. In: Gabler S, Hoffmeyer-Zlotnik JHP (Hrsg): Stichproben in der Umfragepraxis. Opladen: Westdeutscher Verlag, 1997: 99–116
- ¹⁴ Bullinger M, Kirchberger I. Der SF-36 – Fragebogen zum Gesundheitszustand. Handanweisung. Göttingen: Hogrefe, 1998
- ¹⁵ Kolip P. FEW-16. In: Brähler E, Schumacher J, Strauß B (Hrsg): Diagnostische Verfahren in der Psychotherapie. Diagnostik für Klinik und Praxis. Band 1. Göttingen: Hogrefe, 2003: 132–133
- ¹⁶ The WHOQOL Group. The World Health Organization quality of life assessment (WHOQOL): development and general psychometric properties. Social Science and Medicine 1998; 46: 1569–1585
- ¹⁷ The WHOQOL Group. Development of the World Health Organization WHOQOL-BREF quality of life assessment. Psychological Medicine 1998; 28: 551–558
- ¹⁸ Skevington S, Lotfy M, O'Connell K. The World Health Organization's WHOQOL-BREF quality of life assessment: Psychometric properties and results of the international field trial. A report from the WHOQOL group. Quality of Life Research 2004; 13: 229–310
- ¹⁹ Grulke N, Bailer H, Glöckle B. Abschlussbericht über das Projekt „Psychotherapeutische und psychosoziale Interventionen bei Leukämiepatienten unter Blutstammzelltransplantation (SZT) – Eine kontrollierte Therapiestudie zur supportiven Behandlung krankheits- und therapiebedingter Nebenwirkungen zur Verbesserung der Krankheitsbewältigung und der Lebensqualität“. Ulm: Universitätsklinik für Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, 2005